

O advogado que vira plano de saúde

Uma proposta de posicionamento, público e estratégia — pensada pro seu jeito de atuar. Não é o material da agência; é o que eu acho que a gente consegue fazer com ele, e um pouco além.

ESCRITO PARA VILMAR · JULHO DE 2026 · DOCUMENTO INTERNO E CONFIDENCIAL



ANTES DE TUDO

Vilmar,

Recebi o material da agência e passei alguns dias com ele na cabeça. A estratégia deles é boa — o diagnóstico de competir em **velocidade**, e não em quem sabe mais direito, está certíssimo. Mas ficaram três coisas me incomodando, e nenhuma delas está no PDF que mandaram. Resolvi escrever do meu jeito, sem juridiquês e sem aquele tom de agência, pra você bater o olho e me dizer se faz sentido.

A **primeira** é sobre com quem a gente fala de verdade — e não é com o doente. A **segunda** é sobre onde a briga acontece, porque limitar tudo a “plano de saúde” está deixando dinheiro na mesa: contra o SUS funciona igual. A **terceira** é sobre a entrada, o dinheiro — e é aí que eu acho que mora o pulo do gato do seu escritório.

Costurei as três numa ideia só, que dá título a essa proposta. Lê com calma. No fim eu te digo, em quatro linhas, o que preciso de você pra isso sair do papel.

— e sim, tudo aqui cabe dentro da ética da OAB. Já pensei nisso por você.

A gente resolve isso juntos.

ESTRATÉGIA & POSICIONAMENTO

A IDEIA EM UMA FRASE

Pra quem não tem plano, você vira o plano.

A maioria das pessoas que precisa de um tratamento caro não tem plano de saúde — ou tem um que nega na hora H. Quando o tratamento é negado, seja pela operadora, seja pela fila do SUS, alguém precisa entrar e obrigar o sistema a entregar. Esse alguém é você.

O cliente não está comprando uma petição. Está comprando a **certeza de que o tratamento vai acontecer** — que é exatamente o que um plano deveria fazer e não faz. Se ele te contrata quando precisa e você faz o tratamento sair, na prática, na hora que mais importa, você foi o plano de saúde dele. Melhor: um que cumpre.



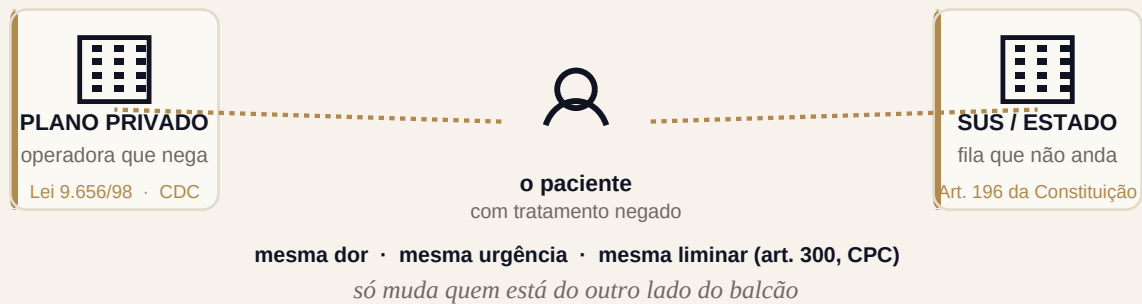
Da esquerda pra direita: o plano que nega (ou que a pessoa nem tem) sai de cena; entra você; e o que o cliente leva pra casa é o tratamento liberado. É essa a promessa — de processo e de presença, nunca de resultado garantido.

ONDE A BRIGA ACONTECE

Parar de mirar só no plano

A agência montou tudo mirando a operadora de plano. O problema é de tamanho de mercado: cerca de **7 em cada 10 brasileiros não têm plano** e dependem do SUS. E o SUS nega igual — medicamento de alto custo, cirurgia, vaga de UTI, terapia que “não está na tabela”. A dor é a mesma; muda só quem está do outro lado do balcão.

Contra o Estado, a base é o **art. 196 da Constituição** (saúde é direito de todos e dever do Estado). Contra o plano, é a Lei 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor. A ferramenta que destrava os dois é a mesma: a **tutela de urgência do art. 300 do CPC**. Ou seja — a mesma competência que você já tem, mirando o dobro de gente.



≈ **7 em 10**

brasileiros dependem do SUS,
não de plano

Art. 196

a Constituição obriga o Estado a
dar saúde

Art. 300

a mesma liminar vale nas duas
frentes

QUEM REALMENTE CONTRATA

Quem liga quase nunca é o próprio paciente

Essa é a virada de chave do público. Na saúde, quem procura o advogado, decide e paga quase nunca é o doente — é a **família**. É a mãe da criança, a filha do idoso, o marido desesperado. Gente movida por amor e por culpa, não por tabela de preço.



MÃE

cuida de criança com TEA



FILHO / FILHA

cuida de pai ou mãe idosos



CÔNJUGE

cuida de adulto em tratamento

Isso muda o anúncio inteiro: a gente fala com **quem cuida**, não com quem está doente. E cuidador com medo de perder alguém não pesquisa preço — pesquisa quem resolve rápido. É o cliente menos sensível a valor que existe, e é justamente o que a mensagem de urgência atrai.

“Quanto custa?” é a segunda pergunta de quem tem medo. A primeira é “você consegue resolver?”. Responda a primeira e a segunda perde a força.

OS DOIS PÚBLICOS QUE NINGUÉM PEGA DIREITO

A criança e a melhor idade

Dentro dessa lógica de família, dois públicos estão órfãos de um advogado que fale com eles — e são os mais recorrentes e emocionais que existem. Eu apostaria as fichas aqui.



PÚBLICO 01 · A CRIANÇA

A criança que precisa de terapia

O autismo (TEA) virou uma das maiores demandas de saúde do país — estimativas internacionais falam em cerca de 1 criança a cada 36. Plano e SUS negam ou cortam a carga horária de terapia que o médico pediu, e cada mês perdido é desenvolvimento que não volta. A mãe entra em pânico — e vira sua melhor propaganda no grupo de outras mães.

O que costuma ser negado: terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, acompanhante terapêutico na escola, canabidiol e as horas de terapia negadas pelo plano.

É recorrente, é emocional e se espalha boca a boca como nenhum outro nicho.



PÚBLICO 02 · A MELHOR IDADE

O idoso que o sistema deixa esperando

Do outro lado da vida, a mesma cena. A família não aceita ver o pai ou a mãe na fila enquanto a saúde piora. Aqui a urgência é literal, e o Estatuto do Idoso ainda dá prioridade na tramitação — a liminar sai mais rápido.

O que costuma ser negado: home care e internação domiciliar, medicamento oncológico e de alto custo, cirurgia negada “por idade” ou “fora do rol”, fisioterapia, fraldas e insumos, cuidador.

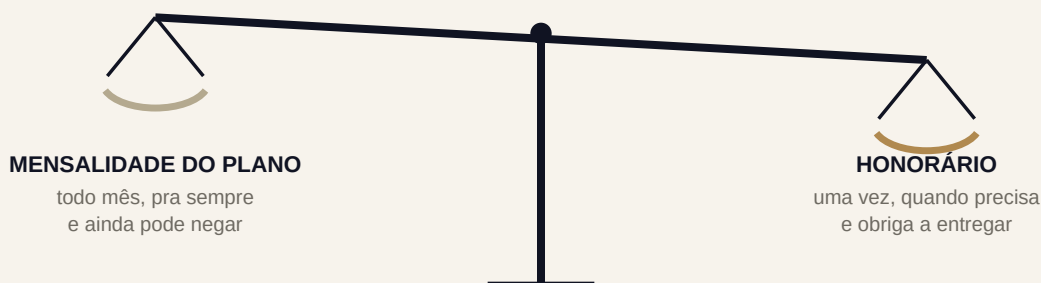
Decisão movida por amor de filho, com prioridade legal de quem já tem idade.

O PULO DO GATO É NO DINHEIRO

Tirar o medo da entrada

A maior objeção nunca é o valor do honorário. É o medo: “e se eu pagar e não der certo?”. Com o público do SUS, esse medo cai sozinho — e é aí que está a sua vantagem. Quem depende do SUS **já não paga plano nenhum**. O dinheiro que iria pra uma mensalidade que nega está livre. Reposiciona o honorário como o que ele é de verdade: o melhor investimento em saúde que essa família pode fazer.

Mais barato que um ano de plano — e esse aqui entrega. Para o cliente do SUS, ainda tem a **gratuidade de justiça**, que derruba as custas do processo: o honorário passa a ser o único gasto, e em troca ele compra a certeza do tratamento. A entrada deixa de ser um custo assustador e vira a coisa mais óbvia do mundo.



o cliente não compra uma petição — compra a certeza do tratamento

Sobre a ética: isso é reposicionamento de valor percebido, não promessa de ganho. Nada de “recupero seu dinheiro” ou “ganho garantido”. A gente vende presença, rapidez e método — o desfecho é sempre da Justiça, e cada peça passa pelo seu ok.

COMO ISSO APARECE — DO SEU JEITO

Autoridade sem aparecer

Eu sei que você não curte aparecer, e quero que fique tranquilo: nesse nicho, isso é **vantagem**, não limitação. Quem está com um filho doente não quer ver advogado dançando trend. Quer ver alguém sério que entende a lei e vai agir. Discrição, aqui, lê como seriedade.

Então a comunicação não depende da sua cara: **reels de texto sem rosto**, cards que explicam direitos, a base legal sempre citada. Sua imagem aparece uma única vez — séria, na foto de perfil — e pronto. É a repetição da mesma mensagem que constrói a autoridade que a exposição construiria em outro tipo de advogado. E, como sempre, nada vai ao ar sem o seu ok: na OAB, quem responde pela publicidade é você.



sem rosto



base legal



uma mensagem só

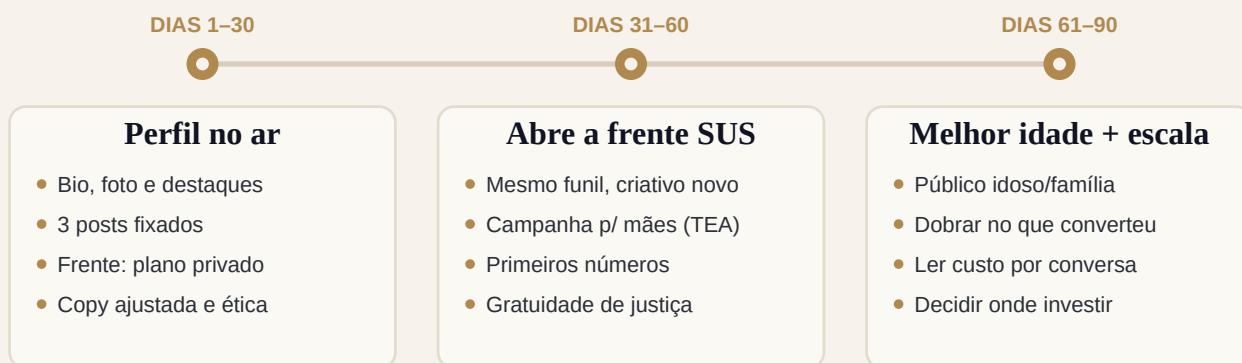


seu ok em tudo

O CAMINHO

90 dias, três frentes

Nada de virar tudo de uma vez. A gente prova o modelo em etapas, com os mesmos R\$ 500 que a agência já planejou, abrindo uma frente nova a cada mês e mantendo só o que der resultado.



O objetivo dos 90 dias não é escalar. É **provar**, com o menor investimento possível, que o protocolo funciona nas duas frentes (plano e SUS) e nos dois públicos (criança e idoso) — e então saber, com número na mão, onde vale a pena colocar mais verba.

PRA COMEÇAR

O que eu preciso de você

São quatro coisas, e nenhuma toma seu dia:

1. Seu número da OAB, pra estampar em perfil e criativos — é o que dá seriedade e cumpre a identificação da publicidade.
2. Três casos antigos, anonimizados, pra eu entender os melhores gatilhos e os erros que a família mais comete.
3. Seu ok pra eu conversar com a agência sobre abrir a frente do SUS e os públicos criança e idoso — sem isso eles seguem mirando só plano.
4. Meia hora sua pra a gente alinhar o tom. O resto eu toco e te trago pronto pra validar.

Se você topa, em 90 dias a gente sabe exatamente que tipo de advogado de saúde o mercado da região está procurando — e você vai estar sendo o plano de saúde de quem nunca teve um.

Bora?

